

Les Conjonctivites

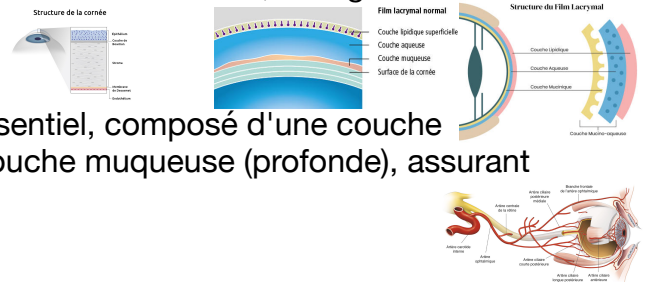
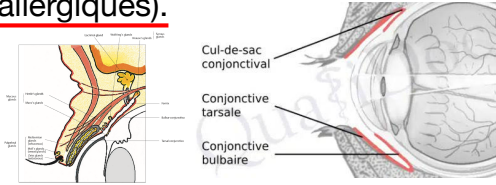
Introduction:

- Les conjonctivites sont des inflammations de la conjonctive.
C'est une affection extrêmement fréquente en ophtalmologie.
- Bien que le pronostic visuel soit généralement bon, il existe des formes graves, notamment la **conjonctivite gonococcique**, qui nécessitent une attention particulière.
- La classification principale se fait entre les **conjonctivites infectieuses** (majoritairement virales et bactériennes) et les **conjonctivites non infectieuses** (principalement allergiques).

Rappels Anatomiques et Physiologiques:

Structure de la conjonctive et la cornée:

- La conjonctive est une membrane muqueuse vascularisée qui recouvre la face antérieure du globe oculaire (à l'exception de la cornée) et la face postérieure des paupières. On distingue :
 - **La conjonctive palpébrale** : recouvrant l'intérieur des paupières, divisée en conjonctive tarsale et conjonctive orbitaire.
 - **La conjonctive bulbaire** : recouvrant la sclère (conjonctive sclérale) et la zone limbique (conjonctive limbique).
 - **Les culs-de-sac conjonctivaux** : zones de jonction entre la conjonctive tarsale et bulbaire.
- **Histologiquement**, la conjonctive est composée d'un épithélium conjonctival, d'une membrane basale et d'un chorion (stroma conjonctival) riche en tissu lâche, collagène et vascularisé.
- **La cornée**, quant à elle, est avasculaire et transparente.
- La surface oculaire est recouverte d'un **film lacrymal** essentiel, composé d'une couche lipidique superficielle, d'une couche aqueuse et d'une couche muqueuse (profonde), assurant hydratation et protection.



Vascularisation:

- **La vascularisation artérielle** de la conjonctive palpébrale provient des artères palpébrales, et celle de la conjonctive bulbaire des artères ciliaires antérieures.
- **Le drainage veineux** se fait vers les veines ophtalmiques pour la conjonctive palpébrale et vers les veines musculaires pour la conjonctive bulbaire.
- **Le drainage lymphatique** aboutit aux ganglions prétragiques, parotidiens et sous-maxillaires, ce qui est cliniquement pertinent en cas d'adénopathie.

Innervation:

- **L'innervation sensitive** est assurée par le nerf ophtalmique (branche du trijumeau), expliquant la douleur ou les sensations de corps étranger.
- **L'innervation sympathique et parasymphatique** régule notamment la sécrétion de mucine, contribuant à la stabilité du film lacrymal.

Role:

- La conjonctive joue un rôle crucial dans la **défense immunologique**, avec des cellules immunocompétentes (cellules de Langerhans) impliquées dans les réactions inflammatoires et la synthèse d'immunoglobulines.
- Les cellules épithéliales ont un rôle de **barrière physique** et possèdent une capacité de phagocytose, notamment contre les virus.

Physiopathologie:

- La physiopathologie des **conjonctivites infectieuses** implique plusieurs étapes :
 1. **Dépassement des défenses de l'hôte** : Les mécanismes de protection normaux sont submergés.

2. **Effraction des barrières épithéliales** : Les agents pathogènes pénètrent l'épithélium conjonctival.
 3. **Multiplication des germes** : L'agent infectieux se développe.
 4. **Réponse inflammatoire de l'hôte** : Le système immunitaire réagit, entraînant les signes cliniques de l'inflammation.
- Les **conjonctivites allergiques** sont le résultat de réactions d'hypersensibilité :
 - **Hypersensibilité immédiate IgE médiée** : C'est le mécanisme le plus courant, impliquant les IgE et la libération d'histamine par les mastocytes.
 - **Hypersensibilité retardée (type 4) à médiation cellulaire Th1** : Plus rare, elle implique les lymphocytes T helper 1 et des réactions inflammatoires plus tardives.

Épidémiologie:

- **La flore conjonctivale normale** est présente chez environ les deux tiers de la population générale. Elle est principalement composée de bactéries telles que *Staphylococcus epidermidis* (le plus fréquent), *Corynebacterium species*, *Staphylococcus aureus*, et *Propionibacterium acnes*. L'Adénovirus est également un virus fréquemment présent.
- L'âge est un facteur important dans l'étiologie des conjonctivites infectieuses :
 - **Nouveau-né**: souvent acquises lors du passage dans la filière génitale. *Chlamydia trachomatis* et *Neisseria gonorrhoeae* sont des causes majeures et graves.
 - **Enfant (< 1 an)** : Les entérocoques coliformes sont fréquents.
 - **Enfant (> 1 an) et adulte** : *Haemophilus influenzae* (45–60 %), *S. aureus* (8–20 %), *Streptococcus pyogenes* et *pneumoniae* (20–30 %), et les *Moraxella* (5–10 %) sont les agents bactériens les plus courants.
- Le mode d'installation permet aussi une classification :
 - **Conjonctivite aiguë (< 4 semaines)** : Majoritairement d'origine infectieuse (bactérienne et virale).
Une forme particulière est la **conjonctivite suraiguë** (24-48h), typiquement gonococcique.
 - **Conjonctivite chronique (> 4 semaines)** : Souvent d'origine allergique.
- La transmission des conjonctivites infectieuses se fait principalement par :
 - **Voie "main-œil"** : Très fréquente en collectivités.
 - **Contamination d'origine nasopharyngée** : Surtout chez les enfants (*Haemophilus* et *S. aureus*).
 - **Contamination oculogénitale** : Notamment par *Chlamydiae* (lors du passage en filière génitale pour le nouveau-né, ou MST chez l'adulte).

Diagnostic Positif:

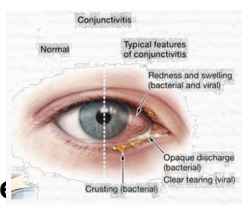
Le diagnostic d'une conjonctivite est avant tout **clinique**.

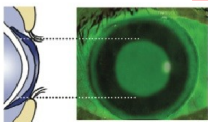
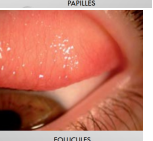
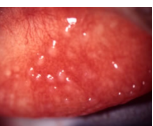
Signes fonctionnels:

- **Sensation de corps étranger**: Fréquente.
- **Larmoiement**: Présent.
- **Photophobie discrète**: Généralement légère, contrairement aux urgences.
- **Prurit**: Démangeaisons, très évocatrices d'une origine allergique.
- Les signes sont souvent **bilatéraux**, soit d'emblée, soit après quelques jours d'évolution.
- **L'acuité visuelle est généralement conservée**, ce qui est un point différenciant majeur avec les urgences oculaires.

Examen ophtalmologique:

- **Mesure de l'acuité visuelle** : Toujours normale, de loin et de près, avec ou sans correction.
- **Sécrétions conjonctivales** : Leur nature (séreuses, purulentes, filaires) est très informative.





• **Rougeur oculaire diffuse** : Caractéristique de l'atteinte conjonctivale.

• **Chémosis** : Œdème de la conjonctive, parfois spectaculaire.

• **Réactions conjonctivales** :

- **Papilles** : Petites excroissances (aspect "pavé de rue") sur la conjonctive tarsale, riches en vaisseaux (central) et cellules inflammatoires.

Typiques des conjonctivites allergiques et bactériennes.

- **Follicules** : Petites élévations translucides, grises ou blanchâtres, sans vaisseau central.

Caractéristiques des conjonctivites virales et chlamydiennes.



- **Fausse membranes** : Peuvent être présentes dans les formes sévères (virales ou bactériennes).

- **Examen ophtalmologique complet** :

- **Cornée** : Doit être transparente. Un test à la fluorescéine est réalisé pour s'assurer de l'absence d'ulcération ou d'érosion, qui orienterait vers une kératite associée.

- **Cristallin, tonus oculaire, fond d'œil** : Généralement normaux, permettant d'éliminer d'autres pathologies.

Examen général:



- **ORL** : Recherche d'otites associées (en particulier chez l'enfant).
- **Adénopathie prétragienne** : Gonflement du ganglion devant l'oreille, fortement évocateur d'une conjonctivite virale (adénovirus).

Examens Complémentaires:

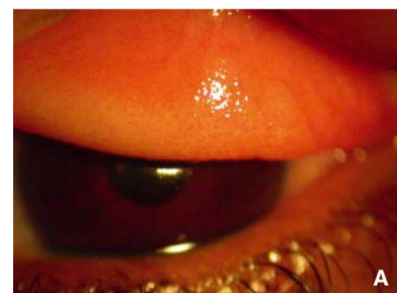
- Les examens bactériologiques ne sont pas systématiques mais sont indiqués dans certains cas:
 - **Conjonctivite du nouveau-né** : Urgence diagnostique et thérapeutique pour identifier *Chlamydia* ou *Gonocoque*.
 - **Ulçère de cornée** : Pour identifier l'agent pathogène et adapter le traitement.
 - **Formes chroniques graves** : Si le traitement initial échoue ou en cas de forme atypique.
- Un bilan allergologique est indiqué en cas de :
 - **Conjonctivite allergique sévère** : Il inclut la recherche d'éosinophilie sanguine ou locale, le dosage des IgE sériques totales et spécifiques, et des tests cutanés (Prick tests) pour identifier l'allergène.

Diagnostic Étiologique:

Les Conjonctivites Infectieuses: Virales

Elles se caractérisent par une conjonctivite:

- Aiguë folliculaire
- Des sécrétions claires
- La présence fréquente d'une adénopathie prétragienne.



Les Conjonctivites à Adénovirus:

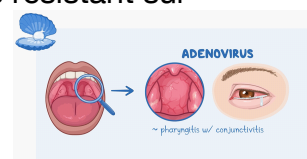
C'est la cause la plus fréquente des conjonctivites virales.

Le virus peut être porté sainement sur la conjonctive et les amygdales, et il est très résistant sur les surfaces inertes (survie jusqu'à 4 semaines), expliquant sa grande contagiosité.

Plusieurs formes cliniques existent:

■ Kérato-conjonctivite épidémique (KCE):

- Touche particulièrement les enfants et jeunes adultes.
- **Très contagieuse**, responsable d'épidémies estivales et hivernales en collectivités.
- Incubation: 8 jours.
- Contagiosité : 3 jours avant et 14 jours après les symptômes.
- Phase infectieuse dure 10 à 21 jours.

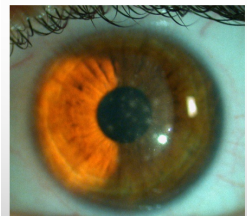


- **Signes cliniques : Souvent bilatérale.**
 - Rougeur oculaire.
 - Œdème palpébral
 - Sécrétions aqueuses abondantes
 - Larmoiement.
 - Hémorragie sous-conjonctivale possible dans les formes sévères.
 - Inconstamment : adénopathie prétragienne, symptômes respiratoires (atteinte des voies respiratoires supérieures) ou gastro-intestinaux.

- **Follicules:** Apparaissent dès la première semaine, principalement dans le cul-de-sac inférieur puis sur la conjonctive tarsale.

- **Complication : la kératite à adénovirus.**

KÉRATITE NUMMULAIRE

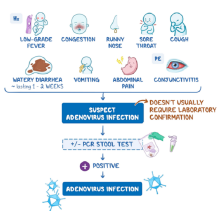


Elle peut être superficielle (ponctiforme) et régresser spontanément, ou évoluer vers une **kératite nummulaire** (infiltration lymphocytaire sous-épithéliale).

Cette dernière entraîne une baisse d'acuité visuelle et une photophobie importante, avec des séquelles possibles comme des opacités cornéennes.

Se caractérise par des opacités en forme de pièces de monnaie siégeant dans le stroma à n'importe quel niveau et de préférence dans la région centrale.

■ Fièvre adéno-pharyngo-conjonctivale :



- **Signes ophtalmologiques :** Conjonctivite aiguë folliculaire, hémorragies conjonctivales, œdème palpébral, sécrétions muqueuses.
- **Signes extra-ophtalmologiques :** Adénopathie prétragienne, pharyngite, céphalées, myalgies, douleurs abdominales, diarrhée, fièvre.

■ Kératoconjonctivite chronique :

- Durée d'évolution > 4 semaines.
- Conjonctivite folliculaire puis papillaire.
- Diagnostic difficile, nécessitant souvent un prélèvement biologique.

Conjonctivites des Herpesvirus:

■ Conjonctivites Herpétiques (HSV1 et HSV2)

- **Primo-infection herpétique :** Se manifeste souvent par:
 - Blépharo-conjonctivite (éruption vésiculaire sur la peau des paupières) avec conjonctivite folliculaire.
 - Adénopathie prétragienne.
 - Guérison spontanée en 3 semaines chez l'immunocompétent.
- **Infections récurrentes :** Conjonctivite folliculaire de durée plus courte, mais risque d'ulcération cornéenne (kératite herpétique), très grave.



■ Conjonctivites à Varicelle Zona Virus (VZV)

- **Conjonctivite de la varicelle :** Conjonctivite folliculaire discrète avec parfois des vésicules conjonctivales hémorragiques. Régression spontanée en 1 ou 2 semaines.
- **Atteinte conjonctivale dans le zona ophtalmique :** Due à la réactivation du VZV dans le ganglion trigéminal. Peut entraîner une conjonctivite folliculaire, des vésicules conjonctivales, des fausses membranes et des ulcérations cornéennes.



Autres Conjonctivites Virales:

Incluent les conjonctivites dues au Pox virus (molluscum contagiosum), à la rougeole et à la rubéole, EBV, HHV-6

Les Conjonctivites infectieuses: Bactériennes

Se caractérisent par:

- Début brutal
- Des sécrétions profuses, épaisses et purulentes
- Une hyperhémie conjonctivale
- Un œdème conjonctival et palpébral
- Une réaction conjonctivale **papillaire**
- L'absence d'adénopathie prétragienne est un élément différenciateur avec les formes virales.



■ Chez l'adulte :

- **Staphylocoque (+++)** : Conjonctivite purulente, parfois associée à des **kératites ponctuées superficielles (KPS)** ou une blépharite.
- **Moraxella** : Conjonctivites prédominantes aux angles externes (**canthite**), avec parfois des lésions érythémateuses cutanées associées.

■ Chez l'enfant :

- **Haemophilus (+++)** : Surtout s'il y a une otite associée. D'autres cocci Gram positif sont possibles.

■ Conjonctivite purulente du nouveau-né : Survient dans les 28 jours après la naissance.

- **Infections à Gonocoque (*Neisseria gonorrhoeae*)** : Pronostic visuel grave, nécessite un prélèvement et un traitement urgent.
- **Chlamydiae** : Peut également causer une conjonctivite néonatale.
- **Staphylocoque** : Récidive fréquente en cas de **sténose du canal lacrymo-nasal**.

QE!!



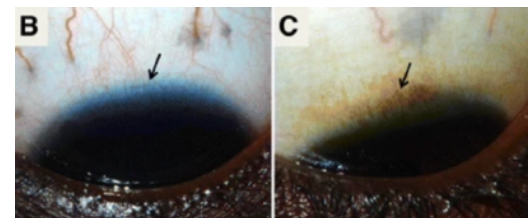
Caractéristique	Conjonctivite bactérienne	Conjonctivite virale
Sensation de corps étranger	Rare	Fréquent
Symptômes généraux	Absents	Possibles (respiratoires)
Sécrétion	Muco-purulente	Aqueuse
Réaction conjonctivale	Papilles+++	Follicules+++
Atteinte cornéenne	Rare	Fréquente
Adénopathie prétragienne	Rare	Fréquente

Les Conjonctivites à Chlamydiae:

Ce sont des conjonctivites bactériennes qui ont tendance à être chroniques.

Conjonctivite à inclusion de l'adulte:

- Hyperhémie
- Larmoiement.
- **Conjonctivite folliculaire chronique.**
- Infiltrats de la périphérie cornéenne (pannus avec néovasclarisation et inflammation).
- C'est une maladie sexuellement transmissible (MST) et le traitement du partenaire est indispensable.



Conjonctivite à inclusions du nouveau-né

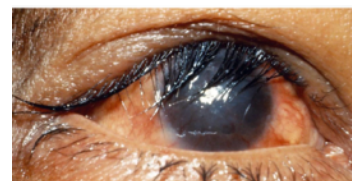
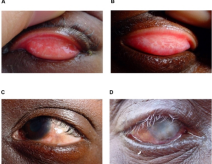
- Acquis pendant l'accouchement (passage par la filière génitale).
- Œdème palpébral, hyperhémie conjonctivale.
- Sécrétions muco-purulentes.
- Ulcérations cornéennes parfois associées.

Maladie de Nicolas et Favre (lymphogranulomatose vénérienne)

- Conjonctivite **folliculaire** et **papillaire**.
- Néo-vascularisation cornéenne.
- Irido-cyclite antérieure.
- Adénopathie prétragienne et sous-maxillaire.

Trachome

- Infection répétée par *Chlamydiae trachomatis*.
- Transmission œil à œil par les sécrétions, manu-portée ou vectorisée par les mouches.
- Transmisssion favorisée par la mauvaise hygiène et la surpopulation.
- **4 stades évolutifs :**
 - **Stade 1 :** Kérato-conjonctivite.
 - **Stade 2 :** Trachome floride (infiltration diffuse du tarse et du limbe).
 - **Stade 3 :** Fibrose conjonctivale.
 - **Stade 4 :** Fibrose cicatricielle (img) avec déformation du tarse, trichiasis (cils déviés et contacte avec le globe = img), entraînant des lésions cornéennes mécaniques (ulcérations, opacités).

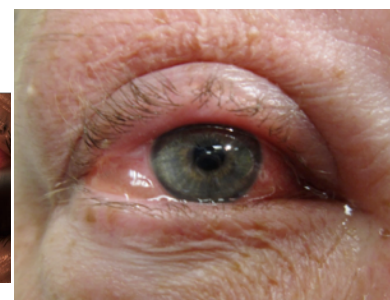


Les Conjonctivites Allergiques:

Les Conjonctivites Allergiques Saisonnières et Per-annuelles

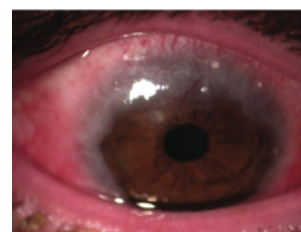
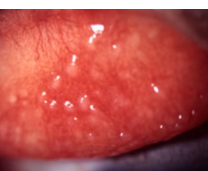
C'est la forme la plus fréquente de conjonctivite allergique.

- **Crises :**
 - Saisonnières (printemps +++): Liées aux pollens.
 - Per-annuelles : Toute l'année (acariens, phanères d'animaux, etc.).
- **Terrain atopique :** Souvent associée à une rhinite allergique.
- **Signes fonctionnels :**
 - **Prurit (démangeaisons) +++ :** Symptôme cardinal.
 - **Larmoiement.**
 - **Rougeur oculaire.**
 - **Signes de sécheresse :** Sensation de sable.
- **Examen ophtalmologique :**
 - **Conjonctivite papillaire.**
 - **Chémosis (œdème conjonctival).**
 - **Œdème palpébral.**
 - **Hyperhémie conjonctivale.**
 - **Sécrétions non purulentes (souvent claires, filaires).**
- **Bilan allergologique :** Indispensable **si la cause n'est pas déterminée**, comprenant des Prick tests et le dosage sérique des IgE.



Kératoconjonctivite Atopique (KCA)

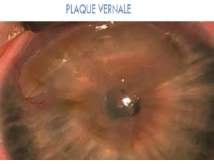
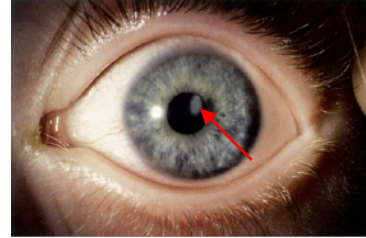
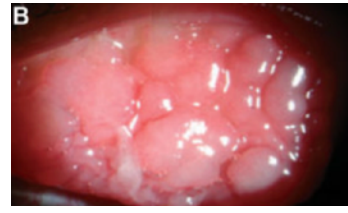
- **L'atopie :** Prédisposition génétique à produire des anticorps IgE en réponse à des allergènes environnementaux.
- **Terrain :** Associée à la dermatite atopique, l'asthme, la rhinite.
- **Signes cliniques :**
 - Prurit intense, picotement oculaire, larmoiement, photophobie.
 - **Signes palpébraux :** Eczéma (peau lichénifiée, fissure, squames), **madarose** (perte des cils).
 - **Conjonctivite papillaire :** Parfois papilles géantes.
 - **Risque de fibrose conjonctivale :** **Symlépharon** (adhérence de la conjonctive bulbaire et palpébrale = img).
- **Complications cornéennes :**
 - Kératites ponctuées superficielles.
 - Ulcère de cornée.
 - Pannus cornéen (néo-vascularisation cornéenne = img).
 - Cicatrice cornéenne opaque.
- **Bilan allergologique :** Indispensable pour l'éviction de l'allergène.



Kérato-conjonctivite Vernale (KCV)

- C'est une forme sévère d'allergie oculaire qui touche l'enfant de moins de 10 ans (surtout les garçons).
- Absence de terrain atopique clairement identifié.

- Disparition après la puberté dans 90% des cas.
- **Signes cliniques :**
 - Symptomatologie plus intense : Rougeur oculaire, photophobie, larmoiement, prurit très important.
- **Examen ophtalmologique :**
 - Hyperhémie conjonctivale.
 - Sécrétions claires mais épaisses.
 - Papilles géantes sous la paupière supérieure (aspect "pavé de rue").
- **Complications cornéennes :**
 - KPS (kératite ponctuée superficielle) dense.
 - **Ulcère vernal** : Perte de substance "à l'emporte-pièce" de la cornée supérieure.
 - **Plaque vernale** : Défaut muqueux solide tapissant le fond de l'ulcère.
 - Cicatrice cornéenne.
 - Néo-vascularisation cornéenne (pannus).



Dermatite de Contact

- **Eczéma lié à une sensibilisation à des allergènes en contact avec la peau :** D'où l'importance de préciser les circonstances de survenue.
- **Paupières :** Lésions érythémateuses prurigineuses, évoluant vers une phase suintante puis croûteuse avec des squames.
- **Les conjonctives :** Conjonctivite folliculaire et papillaire, sécrétions muqueuses possibles.
- **Principaux allergènes :** Métaux (nickel), collyres (conservateurs), cosmétiques.
- **Complications :** Impétiginisation (surinfection bactérienne), ectropion (éversion de la paupière) si chronicité.



Les Conjonctivites Immunologiques (causes rares)

- **Syndrome de Stevens-Johnson :** Réaction cutanéomuqueuse grave, peut entraîner des atteintes conjonctivales sévères.
- **Sarcoïdose :** Maladie inflammatoire systémique qui peut affecter l'œil.
- ...

Diagnostic Différentiel:



- **L'uvéite antérieure :** Douleur intense, photophobie marquée, cercle périkératique, baisse d'acuité visuelle, Tyndall de chambre antérieure.
- **La crise de glaucome aiguë :** Douleur très intense, baisse d'acuité visuelle majeure, halos colorés, œdème cornéen, semi-mydriase aréflexique, œil dur à la palpation.
- **La sclérite et l'épisclérite :** Rougeur localisée, douleur (plus forte dans la sclérite), pas de baisse d'acuité visuelle pour l'épisclérite.
- **Le syndrome sec oculaire :** Rougeur, sensation de sable, mais pas de sécrétions purulentes ou de prurit intense.

Traitement:

Buts:

- **Réduire la durée d'évolution :** Spécifiquement pour les conjonctivites bactériennes.
- **Améliorer la qualité de vie :** Pour les conjonctivites allergiques.
- **Prévenir la perte fonctionnelle et/ou anatomique du globe oculaire.**
- **Éviter la propagation :** Essentiel pour les conjonctivites infectieuses, notamment à Adénovirus, en collectivité.

Moyens:

- **Règles d'hygiène :**

Fondamentales pour prévenir la transmission (lavage des mains, ne pas toucher les yeux).

- **Médicaux :**

- **Sérum physiologique :** Pour les lavages oculaires, essentiel dans les conjonctivites infectieuses et allergiques.
- **Antiseptiques en collyre :** Nitrate d'argent (historiquement pour le nouveau-né), bleu de méthylène.
- **Lubrifiants :** Collyres hydratants pour soulager l'irritation.
- **Collyres antibiotiques :**
 - Usage topique strict (pas d'équivalent par voie générale): Néomycine, bacitracine.
 - Antibiotiques généraux avec présentation à usage local: Rifampicine, chloramphénicol, pénicilline, quinolone, tétracycline.
- **Antibiotique per os :** Dans certains cas d'infection systémique ou de formes sévères.
- **Antiviraux :** Spécifiques (ex: aciclovir pour l'herpès).
- **Collyres corticoïdes :** Utilisés avec précaution et sous surveillance ophtalmologique stricte, car ils peuvent aggraver certaines infections (herpès) ou entraîner un glaucome.

- **Anti-allergiques :**

- **Traitement local :** Antihistaminiques (azélastine, lévocabastine), cromoglycate de sodium (stabilisateur de mastocytes), ciclosporine (formes graves).
- **Traitement général :** Désensibilisation par des antihistaminiques ou cromoglycate de sodium.

Indications:

Conjonctivites Bactériennes :

- Traitement en monothérapie: Collyre le jour et pommade le soir (pour une meilleure observance nocturne).
- Durée de traitement : 8 à 10 jours.
- En cas de résistance ou d'échec : Réaliser un prélèvement avec antibiogramme pour adapter l'antibiotique.
- **Conjonctivite gonococcique du nouveau-né :**
 - Traitement local: Chlortétracycline pommade 1% ou  Azithromycine.
 - Traitement général : Ceftriaxone en IV (très important pour prévenir les complications systémiques et oculaires graves).

Conjonctivite à Chlamydiae :

- Traitement local : Chlortétracycline (Auréomycine).
- Traitement antibiotique par voie générale si infection génitale associée (Érythromycine), avec traitement du partenaire.



Conjonctivites Virales :

- **Conjonctivites virales à Adénovirus :** Traitement symptomatique uniquement.
 - Lavage oculaire au sérum physiologique.
 - Lubrifiants.
 - Les antiviraux ne sont pas efficaces contre l'adénovirus.

Conjonctivites Allergiques :

- **Traitement symptomatique :**
 - Corticothérapie locale : Pendant la crise, pour une courte durée (attention à l'automédication et aux effets secondaires).

- Antihistaminiques + cromoglycate de sodium en collyre.
- Ciclosporine en topique dans les formes graves.
- Correction des facteurs aggravants : sécheresse oculaire avec des lubrifiants.
- **Traitement de fond :**
 - Éviction de l'allergène.
 - Désensibilisation spécifique en collaboration avec l'allergologue.

Prévention:

- **Grande contagiosité des conjonctivites infectieuses** : Les mesures de prévention sont essentielles.
- **Règles d'hygiène** : Lavage fréquent des mains, éviter de se frotter les yeux, ne pas partager de serviettes ou de maquillage.
- **Collectivités** : Éviction scolaire ou arrêt de travail pour les personnes atteintes de conjonctivites infectieuses (notamment virales) pour limiter la propagation.

